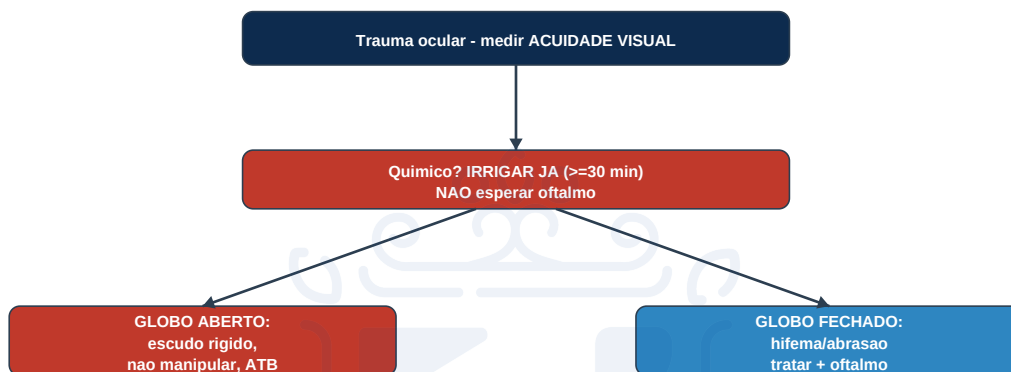


## TRAUMA OCULAR — GLOBO ABERTO x FECHADO

### FLUXOGRAMA — TRIAGEM DO TRAUMA

#### TRAUMA OCULAR — PRIMEIRO, O GLOBO ESTÁ ÍNTEGRO?



### DEFINIÇÃO E CAUSAS

#### O QUE É

- Lesão mecânica, química, térmica ou por radiação do globo e/ou anexos (pálpebras, órbita, vias lacrimais)
- Classificação fundamental: GLOBO ABERTO (ruptura de parede total) x GLOBO FECHADO (parede íntegra)
- Causas: corpos estranhos, trauma contuso (queda/agressão/esporte), penetrante, queimadura química/térmica
- ~50% relacionado ao trabalho em adultos — perguntar sobre EPI

### ANAMNESE E EXAME

#### AValiação

- Anamnese: mecanismo (contuso/penetrante/químico/alta velocidade), tempo, EPI, lente de contato, anticoagulação
- ACUIDADE VISUAL é a informação MAIS IMPORTANTE no trauma ocular — documentar sempre
- Exame externo: pálpebras, conjuntiva, córnea, câmara anterior (hifema/profundidade)
- Pupila: simetria, reflexo, DPAR; movimentos extraoculares (diplopia/restrição)
- PIO só se NÃO houver suspeita de globo aberto; fundoscopia quando possível
- TC de órbita = padrão-ouro (fratura, CE intraocular); pH ocular nas queimaduras químicas

## RED FLAGS — GLOBO ABERTO / GRAVE

### SINAIS DE ALARME

- Ferida penetrante/laceração visível, extrusão de conteúdo, deformidade do globo
- Perda súbita de visão, DPAR (pupila de Marcus Gunn) ou pupila irregular
- Hifema; câmara anterior rasa; sinais de envolvimento intraocular
- Hemorragia retrobulbar (proptose, dor intensa, perda visual progressiva, PIO alta) — emergência
- Fratura de órbita com aprisionamento muscular, diplopia, enoftalmia, enfisema

## CONDUTA POR TIPO DE TRAUMA

| Tipo                 | Conduta imediata                                                                     | Não fazer                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Químico              | Irrigação copiosa IMEDIATA com SF/água $\geq 30$ min (não esperar oftalmo); medir pH | Não atrasar irrigação                     |
| Globo aberto/ruptura | Escudo rígido, jejum, ATB sistêmico, antiemético, antitetânica                       | NÃO manipular/pressionar/instilar colírio |
| Hifema               | Repouso, cabeça 30-45 graus, analgesia, antiemético                                  | Evitar Valsalva e AINE                    |
| Abrasão corneana     | ATB tópico + ciclopégico + AINE tópico + lágrimas                                    | Não tampar olho contaminado               |

## PRESCRIÇÃO — GLOBO ABERTO x ABRASÃO

### Rx GLOBO ABERTO/RUPTURA

Escudo ocular RÍGIDO (nunca curativo compressivo)  
ATB sistêmico: Ciprofloxacino 400mg EV 12/12h +  
Vancomicina 1g EV 12/12h  
(ou Moxifloxacino 400mg VO/dia)  
Antiemético (ondansetrona 4-8mg EV); analgesia (evitar  
AINE; paracetamol/opioides leves)  
Profilaxia antitetânica; jejum; evitar Valsalva; NÃO instilar  
colírios  
Oftalmo de URGÊNCIA para exploração cirúrgica

### Rx ABRASÃO CORNEANA

ATB tópico: tobramicina 0,3% 4/4h (ou eritromicina  
pomada 8/8h)  
Ciclopégico: ciclopentolato 1% 8/8h (conforto)  
AINE tópico: cetorolaco 0,5% 6/6h  
Lágrimas artificiais frequentes + analgesia oral  
Não usar lente de contato até cicatrizar; retorno se piora

## REGRA DE OURO — QUEIMADURA QUÍMICA

### TEMPO É TUDO

- Queimadura química é a ÚNICA emergência ocular que se trata ANTES de qualquer avaliação
- Irrigar copiosamente com SF ou água corrente por no mínimo 30 minutos
- Álcali é mais grave que ácido (penetra mais profundamente — liquefação)
- Medir o pH e continuar irrigando até normalizar; só então avaliar e encaminhar

## CHECKLIST / MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS

### NO GLOBO ABERTO SUSPEITO

- ☐ Protetor ocular rígido (escudo de metal ou copo plástico) — nunca curativo compressivo
- ☐ Repouso absoluto e jejum (cirurgia iminente)
- ☐ Evitar manobras de Valsalva; remover lente de contato
- ☐ Acuidade visual documentada e mecanismo registrado
- ☐ Profilaxia antitetânica verificada

## MODELO DE ENCAMINHAMENTO — URGÊNCIA

### RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Trauma ocular \_\_\_\_ (contuso/perfurante/químico) em OD/OE; mecanismo: \_\_\_\_.
- Achados: AV \_\_\_\_, pupila \_\_\_\_ (em gota?), hifema presente/ausente, DPAR sim/não.
- Conduta: lavagem abundante (se químico) / jejum / escudo rígido / antitetânica / ATB sistêmico.
- Solicito avaliação urgente para exploração cirúrgica ou manejo de complicações (hifema/descolamento).



SM24  
Suporte ao Plantão Médico

## FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

### QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente com respingo de produto de limpeza alcalino no olho há 5 minutos. Qual a PRIMEIRA conduta?

- A) Aguardar avaliação oftalmológica para decidir
- B) Irrigação copiosa imediata com soro fisiológico ou água por no mínimo 30 minutos
- C) Aplicar pomada antibiótica e ocluir o olho
- D) Instilar colírio anestésico e observar
- E) Encaminhar sem nenhuma medida local

### QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Diante de suspeita de globo aberto (ruptura), qual conduta é CORRETA?

- A) Aplicar curativo compressivo firme
- B) Instilar colírio antibiótico e pomada
- C) Proteger com escudo rígido, não manipular nem pressionar, iniciar ATB sistêmico e encaminhar
- D) Medir a pressão intraocular com tonômetro de aplanção
- E) Irrigar sob pressão para limpar a ferida

### QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual é a informação mais importante a ser documentada na avaliação inicial do trauma ocular?

- A) Pressão arterial
- B) Acuidade visual
- C) Tipo sanguíneo
- D) Histórico vacinal completo
- E) Glicemia capilar

### QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Paciente com hifema traumático (sangue na câmara anterior). Qual medida faz parte do manejo correto?

- A) Deambulação livre e esforço físico
- B) Repouso com elevação da cabeça 30-45 graus, analgesia e antieméticos, evitando Valsalva e AINE
- C) Uso de AAS para evitar coágulos
- D) Curativo compressivo bilateral
- E) Irrigação intraocular

### QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Quando a aferição da pressão intraocular (PIO) NÃO deve ser realizada no trauma ocular?

- A) Em qualquer trauma ocular
- B) Quando há suspeita de globo aberto (risco de extrusão de conteúdo)
- C) Quando há apenas hiperemia conjuntival
- D) Em pacientes jovens
- E) Quando a acuidade visual está preservada

## GABARITO COMENTADO

### QUESTÃO 1 → Resposta: B

Queimadura química é a única emergência ocular tratada ANTES da avaliação especializada: irrigação copiosa imediata ( $\geq 30$  min) com SF/água. Álcali penetra por liquefação e é mais grave — não atrasar a lavagem.

### QUESTÃO 2 → Resposta: C

No globo aberto: escudo RÍGIDO, não manipular/pressionar/instilar colírios, ATB sistêmico, antiemético, antitetânica e oftalmo urgente. Curativo compressivo e tonometria de aplanção são contraindicados (risco de extrusão).

### QUESTÃO 3 → Resposta: B

A acuidade visual é a informação mais importante no trauma ocular e principal fator prognóstico; deve ser documentada o quanto antes, em cada olho separadamente.

### QUESTÃO 4 → Resposta: B

Hifema traumático: repouso com cabeceira elevada (30-45 graus) favorece o depósito do sangue, mais analgesia e antieméticos. Evitar Valsalva e AINE/AAS (risco de ressangramento).

### QUESTÃO 5 → Resposta: B

A tonometria é contraindicada na suspeita de globo aberto, pois a pressão sobre o globo pode causar extrusão do conteúdo intraocular. Nesse cenário, protege-se com escudo e encaminha-se.

SM24  
Suporte ao Plantão Médico